

# INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

## PACIENTE

Isabella María Cardona Mejía

### DOCUMENTO

TI 1121000005

### FECHA NACIMIENTO

25/03/2010

### EDAD

16 años, 2 meses

### SEXO

Femenino

### ESCOLARIDAD

10° Secundaria

### LATERALIDAD

Diestra

### FECHA DE EVALUACIÓN

08/06/2026

### ORDEN N°

OM-2026-001238

### PROTOCOLO APLICADO

WISC-IV + CDI + Spence

## INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

|                      |                              |                   |                         |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Nombre:              | Isabella María Cardona Mejía | Lateralidad:      | Diestra                 |
| Documento:           | TI 1121000005                | Ocupación:        | Estudiante              |
| Fecha de nacimiento: | 25/03/2010                   | Ciudad:           | Bogotá, D.C.            |
| Edad:                | 16 años, 2 meses             | Acompañante:      | Roberto Cardona Salazar |
| Sexo:                | Femenino                     | Remite:           | Psicóloga colegio       |
| Escolaridad:         | 10° Secundaria               | EPS / Asegurador: | Compensar EPS           |

## MOTIVO DE CONSULTA

Síntomas depresivos de 4 meses de evolución: tristeza persistente, anhedonia, aislamiento, bajo rendimiento académico. Síntomas ansiosos: preocupación excesiva, insomnio, quejas somáticas.

## PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: WISC-IV + CDI + Spence

| Prueba                     | Dominio                    | Dur. |
|----------------------------|----------------------------|------|
| Diseño con Cubos           | Razonamiento Perceptual    | —    |
| Semejanzas                 | Comprensión Verbal         | —    |
| Vocabulario                | Comprensión Verbal         | —    |
| Claves                     | Velocidad de Proceso       | —    |
| Regresión Dígitos Directos | Memoria de Trabajo         | —    |
| Ind Comp Verb              | Índice CI                  | —    |
| Ind Raz Perce              | Índice CI                  | —    |
| Ind Mem Trab               | Índice CI                  | —    |
| Ind Vel Proce              | Índice CI                  | —    |
| CI total                   | Inteligencia General       | —    |
| CDI Escala de depresión    | Socioemocional - Depresión | —    |
| PAS Total                  | Socioemocional - Ansiedad  | —    |

## ANTECEDENTES

### Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

### Farmacológicos

Sin medicación actual.

### Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

### Psiquiátricos

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

### Traumáticos

Niega TEC previo.

## RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

### Conclusión

Isabella obtuvo un CIT de 104 (promedio), con un perfil asimétrico: IVP=88 es el índice más bajo. El CIT resume pero no captura la variabilidad.

Hallazgos clave

- Velocidad de Proceso severamente descendido ( $Z=-3.0\sigma$ )

Implicación

Se recomienda intervención prioritaria en el dominio con mayor descenso, con seguimiento cercano de la evolución.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Emociones y comportamiento

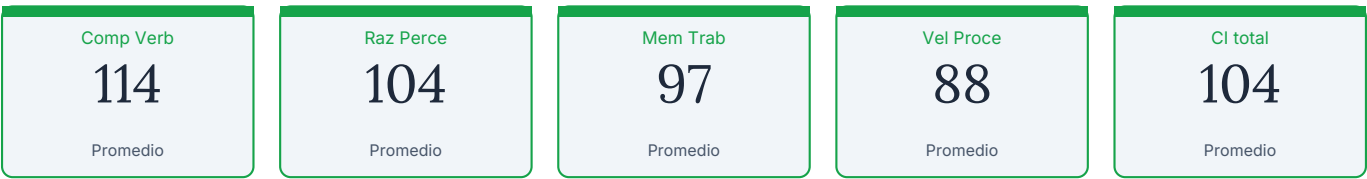
Tristeza persistente, llanto fácil. Anhedonia: 'ya nada me gusta'. Pensamientos de minusvalía. Sin ideación suicida activa.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: F32.1 - Episodio depresivo moderado + F41.1 - Ansiedad generalizada

RESULTADOS CUANTITATIVOS

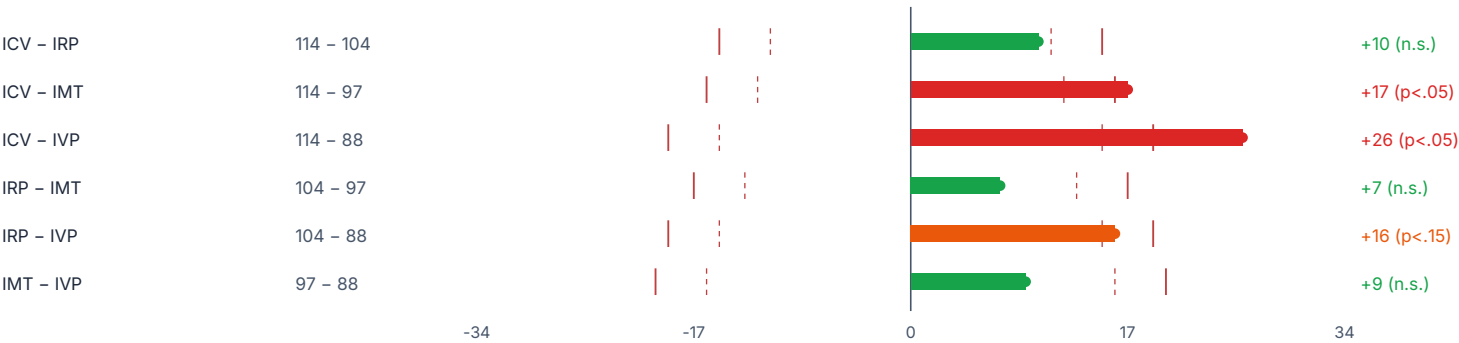
Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente



Discrepancias entre índices

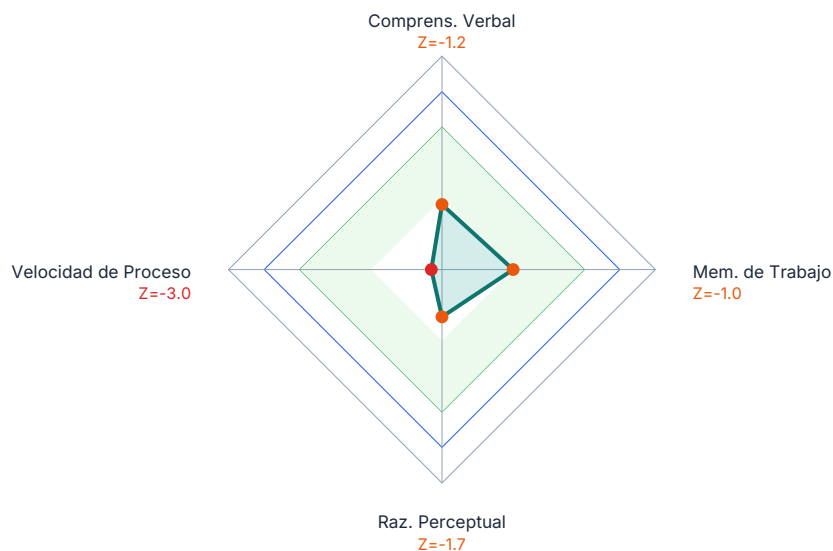
Líneas punteadas: tendencia ( $p<.15$ ). Líneas continuas: diferencia confiable ( $p<.05$ ). La barra central es la diferencia observada entre los dos índices.

Diferencia = valor del primer índice - segundo. Líneas críticas según Wechsler ( $p<.15$  ... y  $p<.05$  ).



## Perfil cognitivo por dominio

Cada eje representa un dominio cognitivo. El polígono teal muestra el Z del paciente; la franja verde central equivale al rango normal (-1 a +1  $\sigma$ ).

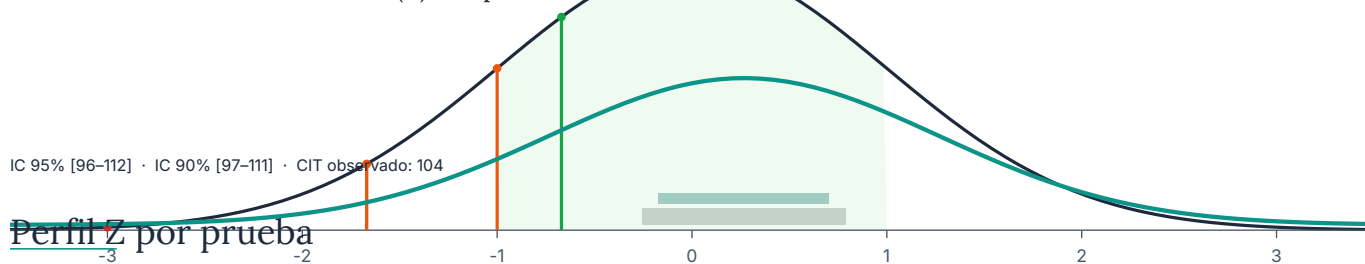


## Curva normal con puntajes Z del paciente

Eje horizontal: puntaje Z (unidades de desviación estándar). Las marcas rojas son los puntajes del paciente sobre la curva.

### Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 5 pruebas con norma disponible



| PRUEBA | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 Z |
|--------|----|----|----|---|---|---|-----|
|--------|----|----|----|---|---|---|-----|

## Perfil por prueba

Eje horizontal: puntaje Z (rango -3 a +3). Verde = zona normal; rojo/naranja = debajo del promedio; azul = por encima.

| PRUEBA                     | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 Z   |
|----------------------------|----|----|----|---|---|---|-------|
| Diseño con Cubos           |    |    |    |   |   |   | -1.67 |
| Semejanzas                 |    |    |    |   |   |   | -0.67 |
| Vocabulario                |    |    |    |   |   |   | -1.67 |
| Claves                     |    |    |    |   |   |   | -3.00 |
| Regresión Dígitos Directos |    |    |    |   |   |   | -1.00 |
| Ind Comp Verb              |    |    |    |   |   |   | +0.93 |
| Ind Raz Perce              |    |    |    |   |   |   | +0.27 |
| Ind Mem Trab               |    |    |    |   |   |   | -0.20 |
| Ind Vel Proce              |    |    |    |   |   |   | -0.80 |
| CI total                   |    |    |    |   |   |   | +0.27 |

Banda verde = rango normal (-1 a +1  $\sigma$ ). Z < -1 sugiere debilidad. Z > +1 sugiere fortaleza relativa.

Semáforo de dominios cognitivos

| DOMINIO                   | Z <sup>-</sup> | BANDA    |
|---------------------------|----------------|----------|
| ● Velocidad de Proceso    | -3.00σ         | severo   |
| ● Razonamiento Perceptual | -1.67σ         | moderado |
| ● Comprensión Verbal      | -1.17σ         | moderado |
| ● Memoria de Trabajo      | -1.00σ         | moderado |

Tabla detallada de puntajes

| Prueba                     | PD  | Escalar/CI | Z     | Interpretación |
|----------------------------|-----|------------|-------|----------------|
| Diseño con Cubos           | 30  | 5          | -1.67 | Límitrofe      |
| Semejanzas                 | 25  | 8          | -0.67 | Promedio       |
| Vocabulario                | 32  | 5          | -1.67 | Límitrofe      |
| Claves                     | 28  | 1          | -3.00 | Bajo           |
| Regresión Dígitos Directos | 15  | 7          | -1.00 | Promedio       |
| Ind Comp Verb              | 38  | 114        | +0.93 | Promedio       |
| Ind Raz Perce              | 32  | 104        | +0.27 | Promedio       |
| Ind Mem Trab               | 19  | 97         | -0.20 | Promedio       |
| Ind Vel Proce              | 16  | 88         | -0.80 | Promedio       |
| CI total                   | 105 | 104        | +0.27 | Promedio       |
| CDI Escala de depresión    | 22  | —          | —     | Sin dato       |
| PAS Total                  | 65  | —          | —     | Sin dato       |

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

Isabella obtuvo un Cociente Intelectual Total (CIT) de 104, ubicándose en la categoría promedio (percentil aproximado 61). Se observa una variabilidad relevante entre sus índices compuestos: el más bajo corresponde a IVP (88) y el más alto a ICV (114), lo que sugiere un perfil asimétrico que conviene analizar por separado más que resumir en una única puntuación global.

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: velocidad de proceso (severamente disminuido, Z=-3.0); razonamiento perceptual (moderadamente disminuido, Z=-1.7); comprensión verbal (moderadamente disminuido, Z=-1.2); memoria de trabajo (moderadamente disminuido, Z=-1.0).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Claves (Z=-3.00, bajo); Diseño con Cubos (Z=-1.67, límiterofe); Vocabulario (Z=-1.67, límiterofe). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Claves — bajo (Z=-3.00)
- Diseño con Cubos — límiterofe (Z=-1.67)
- Vocabulario — límiterofe (Z=-1.67)
- Regresión Dígitos Directos — promedio (Z=-1.00)

# RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

## Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Isabella. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

## ¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

## ¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En Semejanzas, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En Regresión Dígitos Directos, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En Ind Comp Verb, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En Diseño con Cubos, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca. En Vocabulario, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca. En Claves, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.

## Implicaciones para la vida diaria

Además de los puntajes, esto es lo que podría notarse en la vida cotidiana:

### Velocidad de Proceso · severo

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

### Razonamiento Perceptual · moderado

- Armar rompecabezas, mapas o instrucciones de muebles.
- Entender relaciones espaciales (izquierda-derecha, arriba-abajo, rotar mentalmente).
- Resolver problemas lógicos nuevos.

Apoyos sugeridos: Practicar con rompecabezas, tangram, cubos de Kohs, videojuegos de lógica. · Usar material concreto (cubos, figuras) para aprender conceptos abstractos.

### Comprensión Verbal · moderado

- Entender el lenguaje oral complejo o abstracto.
- Seguir instrucciones verbales largas.
- Captar ironías, metáforas o dobles sentidos.

Apoyos sugeridos: Lectura dialogada: leer y comentar lo leído con alguien más. · Pedir que expliquen las cosas con ejemplos concretos.

### Memoria de Trabajo · moderado

- Hacer una operación mental mientras se recuerda otra cosa (ej. contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7).
- Anotar un teléfono mientras se escucha otra indicación.
- Seguir una receta de cocina o instrucciones de varios pasos.

Apoyos sugeridos: Repetir en voz alta lo que se acaba de escuchar. · Anotar inmediatamente la información importante.

## Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En Semejanzas, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Regresión Dígitos Directos, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Ind Comp Verb, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Ind Raz Perce, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Ind Mem Trab, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Diseño con Cubos, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En Vocabulario, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En Claves, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.

## ¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

## Preguntas frecuentes

### ¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica, con los apoyos adecuados y con un buen ambiente. Estos resultados son una foto del momento actual: tu psicólogo/a te ayudará a entender qué puede cambiar y qué se mantiene más estable.

### ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto NO significa que haya algo mal: el cerebro humano es diverso y cada uno tiene su propio perfil.

### ¿Qué significa un puntaje 'bajo' o 'muy bajo'?

Significa que, comparado con personas de la misma edad y nivel educativo, esa función específica rindió por debajo de lo esperado. NO es un diagnóstico en sí mismo. Es una señal para profundizar, entrenar y apoyar esa área. Tu psicólogo/a te explicará si requiere intervención profesional adicional.

### ¿Qué es el 'cociente intelectual' (CI)?

El CI es un número que resume el rendimiento global en diversas pruebas. NO define tu inteligencia total ni tu valor como persona: es solo una medida parcial de ciertas habilidades de razonamiento, memoria y atención. Varía según el contexto, la fatiga, el ánimo del día y muchos otros factores.

## IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

### Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F32

Impresión diagnóstica: F32.1 - Episodio depresivo moderado + F41.1 - Ansiedad generalizada

## RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.

### Recomendaciones del cuadro clínico

Banco de recomendaciones clínicas sugeridas para el cuadro identificado. El clínico debe seleccionar las aplicables antes de emitir el informe definitivo.

### Trastornos específicos de aprendizaje — Dislexia/Disgrafía/Discalculia (F810–F812) · Infantil / Adolescente

- Refuerzo pedagógico especializado (maestro de apoyo) enfocado en el área de mayor dificultad.
- Método multisensorial (Orton-Gillingham) para dislexia: integrar visual, auditivo y kinestésico.
- Uso de tecnología asistiva: audiolibros, lector de pantalla, corrector ortográfico.
- Adaptaciones académicas: tiempos extendidos, evaluación oral, reducción de carga escrita.
- Fonoaudiología para conciencia fonológica (dislexia) y grafomotricidad (disgrafía).
- Terapia ocupacional si hay compromiso grafomotor o visoespacial.
- Psicoeducación al niño y la familia: el diagnóstico no implica menor inteligencia.
- Acompañamiento emocional para prevenir baja autoestima académica.